UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Urgences et réanimation

Brulure

sans patient

sans geste clinique

Nom du rédacteur : Guéna Fabienne **Date de rédaction : décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° (168) – (Brulure)

Domaine de compétence n°1 : (Iconographie)

Domaine de compétence n°2 : (Stratégie de prise en charge)

Attendus d'apprentissage de la situation abordée

1- Evaluer la profondeur des brulures

2- Identifier les localisations à risque

3- proposer une prise en charge antalgique multimodale

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Une photographie d'une brulure au deuxième degré superficiel et une photographie d'une brulure au troisieme degré

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences d'un CHU. L'infirmière vous a apporté les photographies de deux lésions cutanées d'un patient de 33 ans victime de brulures, à la suite d'un accident domestique. Elle rapporte que le patient a des douleurs qu'il évalue à 9,5/10 et vous demande de l'aide pour le soulager immédiatement.

Pas de patient sur la station.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Identifier le degré de profondeur de la brulure pour chacune des photographies et donner deux signes cliniques associés au degré de brulure retrouvé.
2. Enoncer trois signes de gravité d'une brulure (*circonstances, localisation, étendue…)*
3. Enoncer votre prise en charge antalgique immédiate et de première intention

Vous ne devez pas :

- *Evoquer la prise en charge de la brulure autre que l'antalgie*
- *Enoncer les signes cliniques associés aux autres degrés de brulure non présents sur les photographies*

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

	Cocher si fait
Tache 1	
Identifie sur la première photographie une brulure au deuxième degré superficiel	4
Identifie sur la deuxième photographie une brulure du troisième degré	4
Enonce deux signes cliniques en rapport avec une brulure du deuxième degré superficiel parmi les suivants: - présence de phlyctènes, - sensibilité cutanée conservée, - derme rouge et bien vascularisé, douleur spontanée	5
Enonce deux signes clinique en rapport avec une brulure du troisième degré: - tégument épaissi et rigide, - aspect cartonné ou marron de la peau, - présence de nécrose, insensibilité ou hypoesthésie totale de la peau, - absence de douleur spontanée, - destruction des phanères *(follicule pileux, glandes sudoripares, terminaisons nerveuses)*	5
Tache 2	
Enonce trois signes de gravité d'une brulure parmi les suivants: - surface brulée > 10 % (*ou >20% accepté egalement*) - brulure d'une zone à risque vital (*cou, gorge, voies aeriennes*) - brulure d'une zone fonctionnelle (*visage, périnée, mains, membres*) - brulure circulaire - exposition/inhalation de fumées d'incendie - brulure par un agent vunérant (*brulure chimique ou brulure électrique*), - traumatisme associé - trouble de la conscience associé - terrain du patient (*age < 3 ans ou > 60 ans*) - score de Baux > 100 (*age du patient + surface brulée)*	6
Tache 3	
Explique qu'une douleur avec une echelle numérique > 6/10 est une douleur intense nécessitant d'emblée un traitement par pallier 3 (en intraveineux)	2
Enonce qu'il réalise une tritation morphinique	3
Enonce qu'il associe un palier 1 (paracetamol ou néfopam/acupan) au pallier 3	3
Evoque une prise en charge multimodale de la douleur	2
Evoque la réévaluation systématique de la douleur de façon rapprochée pour adapter son traitement par une échelle parmi: - échelle visuelle analogique	2

- échelle numérique - échelle verbale simple	
Evoque que le traitement antalgique est jugé suffisant quand le patient cote sa douleur : - <3/10 à l'échelle numérique - < 30 mm sur une échelle visuelle analogique	1
Evoque la nécessité d'une surveillance de la fréquence respiratoire lors de la tritation morphinique	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitiude à proposer une prise en charge	

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Identifie sur la première photographie une brulure au deuxième degré superficiel	4
Identifie sur la deuxième photographie une brulure du troisième degré	4
Enonce deux signes cliniques en rapport avec une brulure du deuxième degré superficiel parmi les suivants: présence de phlyctènes, sensibilité cutanée conservée, derme rouge et bien vascularisé, douleur spontanée	2,5 points par signe
Enonce deux signes clinique en rapport avec une brulure du troisième degré: tégument épaissi et rigide, aspect cartonné ou marron de la peau, présence de nécrose, insensibilité ou hypoesthésie totale de la peau, absence de douleur spontanée, destruction des phanères (follicule pileux, glandes sudoripares, terminaisons nerveuses)	2,5 points par signe
Tache 2	
Enonce trois signes de gravité d'une brulure parmi les suivants: surface brulée > 10 % (ou >20% accépté egalement), brulure d'une zone à risque vital (cou, gorge, voies aeriennes), brulure d'une zone fonctionnelle (visage, périnée, mains, membres), brulure circulaire, exposition/inhalation de fumées d'incendie, brulure par un agent vunérant (brulure chimique ou brulure électrique), traumatisme associé, trouble de la conscience associé, terrain du patient (age < 3 ans ou > 60 ans), score de Baux > 100 (age du patient + surface brulée), pathologies graves du patient aggravant le pronostic	2 points par signe
Tache 3	

Explique qu'une douleur avec une echelle numérique > 6/10 est une douleur intense nécessitant d'emblée un traitement par pallier 3 (en intraveineux)	2
Enonce qu'il réalise une tritation morphinique	3
Enonce qu'il associe un pallier 1 (paracétamol ou néfopam/acupan) au pallier 3	3
Evoque une prise en charge multimodale de la douleur	2
Evoque des techniques non médicamenteuses asoociées: relaxation, réassurance, hypnose	2
Evoque la réévaluation systématique de la douleur de façon rapprochée pour adapter son traitement par une échelle parmi: l'echelle visuelle analogique, l'échelle numérique ou l'echelle verbale simple	1
Evoque que le traitement antalgique est jugé suffisant quand le patient cote sa souleur <3/10 à l'échelle numérique ou < 30 mm sur une échelle visuelle analogique	2
Evoque la nécessité d'une surveillance de la fréquence respiratoire lors de la tritation morphinique	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	Echelle de 1 à 5 Total /50
Aptitiude à proposer une prise en charge	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur